

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El **Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS)** constituye el **paradigma rector** del sistema público chileno contemporáneo. Este modelo reemplaza progresivamente la visión biomédica tradicional —centrada en la enfermedad y el individuo— por una **mirada biopsicosocial, familiar y comunitaria**, donde la salud es entendida como un proceso dinámico y determinado socialmente.

El **MINSAL** adoptó este modelo en 2005, en el marco de la Reforma de Salud, para fortalecer la **Atención Primaria (APS)** como eje del sistema. El MAIS es, por tanto, la **columna vertebral del trabajo clínico, sanitario y comunitario del médico general** en Chile.

En el contexto del **EUNACOM**, el modelo es evaluado tanto en su dimensión conceptual (principios, enfoque familiar, niveles de prevención) como en su **aplicación práctica en la APS**, siendo esencial para comprender la gestión de casos, la promoción de salud y la continuidad del cuidado.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. De la medicina curativa al enfoque integral

Modelo	Características	Limitaciones
Biomédico	Centrado en enfermedad, cuerpo y tratamiento.	Fragmenta la atención; ignora determinantes sociales.
Biopsicosocial	Considera dimensiones biológicas, psicológicas y sociales.	Necesita equipos multidisciplinarios y continuidad.

Integral – Familiar y Comunitario

Promueve salud, previene enfermedad y aborda contexto familiar y territorial.

Requiere coordinación intersectorial y enfoque participativo.

2.2. Definición del Modelo de Atención Integral (MINSAL)

“El MAIS es la estrategia mediante la cual se busca dar respuesta a las necesidades de salud de las personas, familias y comunidades, desde una atención integral, continua, equitativa y centrada en las personas, con enfoque familiar y comunitario.”

(MINSAL, *Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria*, 2013)

2.3. Principios orientadores del MAIS

1. **Integralidad:** aborda promoción, prevención, recuperación y rehabilitación.
 2. **Continuidad del cuidado:** seguimiento longitudinal y contrarreferencia efectiva.
 3. **Enfoque familiar:** la unidad de análisis no es solo la persona, sino su familia.
 4. **Enfoque comunitario:** considera el territorio y la participación social.
 5. **Equidad:** prioriza a grupos vulnerables y reduce desigualdades.
 6. **Intersectorialidad:** coordinación con educación, trabajo, medioambiente, etc.
 7. **Participación social:** fomenta corresponsabilidad entre comunidad y equipo de salud.
-

3. Marco teórico y determinantes de la salud

El MAIS se fundamenta en los **determinantes sociales de la salud (DSS)**, definidos por la OMS como “las condiciones sociales en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen”.

El enfoque integral considera que el **estado de salud** resulta de la interacción de:

- Factores biológicos (genética, edad, sexo).
- Factores conductuales (hábitos de vida).
- Factores sociales y ambientales (educación, vivienda, trabajo).

- Acceso y calidad de los servicios de salud.

Pirámide de Dahlgren y Whitehead (1991)

Representa gráficamente la multicausalidad de la salud: desde factores individuales hasta estructurales (políticas públicas, desigualdad).

4. Componentes operativos del modelo

4.1. Niveles de intervención

Nivel	Enfoque	Ejemplo
Individual	Persona como eje del cuidado, con plan personalizado de salud.	Control de hipertenso.
Familiar	Dinámica familiar como factor protector o de riesgo.	Entrevista familiar, ficha familiar, visitas domiciliarias.
Comunitario	Intervenciones sobre el territorio y redes locales.	Cabildos de salud, diagnóstico participativo, ferias saludables.

4.2. Ejes estratégicos del MAIS

- 1. Cuidado integral centrado en las personas.**
- 2. Gestión del riesgo y enfoque de ciclo vital.**
- 3. Trabajo interdisciplinario e intersectorial.**
- 4. Continuidad y coordinación de la atención.**
- 5. Participación activa de la comunidad.**
- 6. Uso de información sanitaria local para la gestión.**

4.3. Enfoque de ciclo vital

El modelo organiza las intervenciones según etapas del ciclo vital:

- Niñez (salud infantil, vacunación, desarrollo).
- Adolescencia (salud sexual, salud mental, estilos de vida).
- Adulthood (control cardiovascular, salud mental, salud ocupacional).
- Vejez (envejecimiento activo, dependencia, apoyo social).

Este enfoque permite planificar acciones pertinentes a cada grupo etario y riesgo específico.

5. El enfoque familiar

5.1. Concepto

El **enfoque familiar** concibe a la familia como **unidad básica de salud y enfermedad**, donde los procesos biológicos y emocionales están determinados por la estructura y funcionamiento familiar.

5.2. Herramientas operativas

Herramienta	Descripción	Aplicación
Ficha Familiar	Registro del grupo familiar, riesgos y determinantes.	Base para el diagnóstico y plan de salud familiar.
Genograma	Representación gráfica de estructura familiar y vínculos.	Identifica patrones hereditarios o emocionales.
Ecomapa	Muestra las relaciones entre la familia y su entorno social.	Evalúa redes de apoyo y aislamiento social.

Entrevista familiar

Instrumento clínico para evaluar roles, comunicación y recursos.

Aplica en controles o visitas domiciliarias.

5.3. Clasificación de familias según riesgo (MINSAL)

- **Bajo riesgo:** dinámicas protectoras y funcionamiento adecuado.
- **Riesgo medio:** eventos críticos o conflictos temporales.
- **Alto riesgo:** violencia, consumo de sustancias, negligencia, pobreza extrema.

Esta clasificación permite priorizar recursos y orientar intervenciones diferenciales.

6. Enfoque comunitario

6.1. Definición

“El conjunto de acciones que promueven la participación de la comunidad organizada en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de sus problemas de salud.” (MINSAL, 2015)

6.2. Instrumentos de trabajo comunitario

- Diagnóstico participativo local de salud.
- Planes comunales de promoción.
- Mesas intersectoriales de salud.
- Consejos de Desarrollo Local (CDL).

6.3. Rol del equipo de salud

Facilitar la participación y empoderamiento comunitario, evitando intervenciones verticales o paternalistas.

7. Continuidad del cuidado y trabajo en red

El MAIS promueve la **coordinación entre niveles de atención**, evitando fragmentación.

- Derivaciones desde APS a niveles secundarios deben incluir **contrarreferencia** para garantizar seguimiento.
- El **médico general** coordina y lidera este proceso, asegurando **continuidad clínica y administrativa**.

La red se concibe como un **sistema único e integrado**, donde la APS actúa como puerta de entrada y eje coordinador.

8. Gestión clínica y del riesgo

La gestión clínica dentro del MAIS se basa en:

- **Identificación de grupos de riesgo.**
- **Seguimiento longitudinal de condiciones crónicas.**
- **Intervenciones de promoción y autocuidado.**

Ejemplo:

Paciente hipertenso y obeso → seguimiento por equipo cardiovascular, plan alimentario, control psicosocial y promoción de actividad física con la comunidad local.

9. Rol del médico general en el Modelo Integral

El médico general en APS debe:

1. Abordar la salud **de manera integral, centrada en la persona y su familia**.
2. Identificar factores de riesgo y determinantes sociales.
3. Trabajar interdisciplinariamente (enfermería, psicología, trabajo social, odontología).
4. Liderar el cuidado longitudinal y la continuidad asistencial.
5. Promover la educación en salud y la participación comunitaria.
6. Actuar como referente técnico y ético del equipo de salud familiar.

7. Utilizar herramientas familiares y comunitarias en la práctica cotidiana.
-

10. Normativa chilena relevante

- MINSAL. Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria (2013).
 - Plan Nacional de Promoción de la Salud. Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables.
 - Ley N° 19.937 de Autoridad Sanitaria.
 - Política Nacional de Salud 2021–2030.
 - Manual de Estrategia de Promoción de la Salud (MINSAL, 2018).
-

11. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que el MAIS se aplica solo en APS	Se aplica en todos los niveles, pero su eje es la APS.
Confundir enfoque familiar con atención domiciliaria	El enfoque familiar implica análisis integral del contexto, no solo visitas.
Considerar la comunidad como “beneficiaria” y no como actor activo	El enfoque comunitario busca participación y corresponsabilidad.
Pensar que el modelo se opone a la medicina curativa	La integra, pero con énfasis en prevención y promoción.

Olvidar el rol de intersectorialidad

Salud depende también de vivienda, educación, trabajo, medio ambiente.

Limitar el rol médico a lo clínico

El médico es también educador, gestor y agente comunitario.

12. Aplicaciones en la práctica

Ejemplo 1:

Mujer de 40 años, hipertensa, jefa de hogar con tres hijos adolescentes. El médico del CESFAM planifica atención integrada: control cardiovascular, derivación a nutricionista, entrevista familiar y participación en taller comunitario.

Ejemplo 2:

Diagnóstico participativo comunal detecta alta obesidad infantil. El equipo de salud diseña junto a la escuela y municipio un programa intersectorial de alimentación saludable y actividad física.

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. El **Modelo de Atención Integral (MAIS)** orienta todo el sistema público chileno hacia una atención **centrada en las personas, familias y comunidades**.
2. Sustituye la visión biomédica por una **mirada biopsicosocial, familiar, comunitaria y territorial**.
3. Se apoya en principios de **integralidad, continuidad, equidad, participación e intersectorialidad**.
4. El **enfoque familiar** considera la familia como unidad de salud y utiliza herramientas específicas (genograma, ecomapa, ficha familiar).
5. El **enfoque comunitario** busca empoderar a la población en la identificación y solución de sus problemas de salud.
6. El médico general es **líder del equipo APS**, garante de continuidad del cuidado y articulador entre niveles.

7. Este modelo es **transversal al EUNACOM**: su comprensión es esencial para abordar casos clínicos, gestión local y preguntas teóricas.